MÓDULO 6 · MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA MSLS

NNT, NNH y relevancia clínica

El número necesario a tratar (Number Needed to Treat, NNT) es, según la literatura metodológica, una de las herramientas más intuitivas para trasladar los resultados de un ensayo clínico a una decisión práctica: indica cuántos pacientes deben recibir el tratamiento durante el periodo estudiado para que uno de ellos evite el evento adverso o alcance el resultado deseado, en comparación con el grupo control. Su versión inversa, el número necesario para dañar (Number Needed to Harm, NNH), indica cuántos pacientes deben ser tratados para que uno de ellos sufra un efecto adverso adicional atribuible al tratamiento.

NNT Y NNH

- NNT: pacientes que deben tratarse para que uno evite el evento
- NNH: pacientes que deben tratarse para que uno sufra un efecto adverso
- Traducen el resultado del ensayo a una decisión práctica

Matemáticamente, el NNT es el recíproco de la reducción absoluta del riesgo (NNT = 1 / RAR, donde RAR es la diferencia entre la tasa de eventos del grupo control y la del grupo tratado, expresada como proporción). Esta fórmula explica por qué el NNT es tan sensible al riesgo basal de la población: el mismo riesgo relativo puede traducirse en un NNT muy distinto según cuán frecuente sea el evento en la población de partida. Un NNT bajo (por ejemplo, 5) indica que el tratamiento es muy eficiente —pocos pacientes deben tratarse para lograr un beneficio—; un NNT alto (por ejemplo, 200) indica que el beneficio, aunque real y estadísticamente significativo, se diluye entre muchos pacientes tratados sin beneficio directo observable.

CÓMO SE CALCULA EL NNT

- NNT = 1 / reducción absoluta del riesgo (RAR)
- Muy sensible al riesgo basal de la población estudiada
- NNT bajo (ej. 5) = eficiente; NNT alto (ej. 200) = beneficio diluido

La gran fortaleza del NNT es que comunica magnitud de efecto absoluto en un lenguaje directamente interpretable por cualquier clínico, a diferencia de las medidas relativas como el riesgo relativo o el hazard ratio, que pueden hacer que un beneficio pequeño en términos absolutos "suene" más grande de lo que es en la práctica. Por eso, la literatura clínica actual recomienda de forma creciente reportar NNT y NNH junto a las medidas relativas, especialmente al comunicar resultados a audiencias no especializadas en bioestadística.

- Comunica la magnitud absoluta en un lenguaje directamente interpretable
- A diferencia de las medidas relativas, no exagera el beneficio percibido
- Se recomienda reportarlo junto a las medidas relativas, sobre todo a audiencias no especializadas

El NNT tiene también limitaciones que un MSL debe conocer. Es válido únicamente para el periodo de seguimiento del estudio del que se deriva —no puede extrapolarse sin más a un horizonte temporal distinto—; es específico de la población estudiada, por lo que aplicarlo a una población con un riesgo basal muy diferente (más joven, más sana, con menos comorbilidades) puede ser engañoso; y, al ser un promedio poblacional, no informa sobre la probabilidad individual de beneficio de un paciente concreto, que depende de sus propias características.

LIMITACIONES DEL NNT

- Válido solo para el periodo de seguimiento del estudio del que se deriva
- Específico de la población estudiada; puede ser engañoso en otra distinta
- Al ser un promedio poblacional, no informa el beneficio individual

Para el MSL, el valor práctico del NNT y el NNH está en construir una conversación de riesgo-beneficio equilibrada: presentar el NNT del beneficio principal junto al NNH del efecto adverso más relevante permite que el HCP visualice, con un mismo lenguaje numérico, ambos lados de la balanza terapéutica, y facilita una discusión genuinamente informada con el paciente en la consulta —que es, en última instancia, el objetivo de toda comunicación científica no promocional.

- Presentar el NNT del beneficio junto al NNH del efecto adverso más relevante
- Permite al HCP visualizar ambos lados de la balanza terapéutica
- Facilita una discusión genuinamente informada con el paciente en consulta